



EXAMEN BLANC DE RESIDANAT

année universitaire 2025-2026

Epreuve 1 (B)
65 QCM et 16 cas cliniques
avec correction
21 Octobre 2025

Cette épreuve comprend 65 QCM et 16 cas cliniques

Partie A : QCM

Veillez inscrire les réponses aux QCM dans la grille réservée aux QCM

1. **La thrombose du sinus caverneux comporte :**
 - A) Une exophtalmie
 - B) Une atteinte du IV
 - C) Un myosis
 - D) Des crises épileptiques.
 - E) Une atteinte du V2
2. **On évoque un AVC hémorragique devant :**
 - A) Une symptomatologie neurologique du réveil
 - B) **Des troubles de la conscience**
 - C) Une symptomatologie Crescendo
 - D) **Un œdème papillaire**
 - E) **Des crises épileptiques inaugurales**
3. **L'appendicite aigue gangréneuse est caractérisée sur le plan anatomopathologique par :**
 - A) La présence de pus dans la lumière appendiculaire
 - B) Une inflammation superficielle limitée à la muqueuse appendiculaire
 - C) Une Infection diffuse généralisée de la cavité abdominale
 - D) Une infiltration des structures de voisinage de l'appendice
 - E) **Une ischémie et une nécrose de la paroi appendiculaire**
4. **L'appendicite rétro-caecale est caractérisée par :**
 - A) Une douleur franche de la fosse iliaque droite
 - B) Une diarrhée manifeste
 - C) Une occlusion intestinale aigue
 - D) **Un psoitis**
 - E) **Une douleur mise en évidence en décubitus latéral gauche**
5. **L'appendicectomie lors d'une appendicite aigue dans sa forme classique peut être réalisée par :**
 - A) Une incision inguinale droite
 - B) Une incision sous costale droite
 - C) **La voie coelioscopique**
 - D) **Une incision de McBurney**
 - E) Une incision médiane

6. La mortalité post appendicectomie est de :
- A) 5%
 - B) 50%
 - C) 20%
 - D) 0,5 %**
 - E) 10%
7. L'asthme de l'enfant est évoqué devant les situations cliniques suivantes :
- A) Une toux récurrente d'exacerbation diurne
 - B) Une oppression thoracique pendant les épisodes grippaux**
 - C) Une toux exacerbée par les rires et l'effort
 - D) Une dyspnée expiratoire améliorée par la corticothérapie
 - E) Des dyspnées sifflantes récidivantes hivernales
8. Les données spirométriques en faveur de l'asthme chez l'enfant sont :
- A) Un VEMS/CVF < 0,9 à l'état de base
 - B) Une baisse du DEP de 15 % après un effort physique intense**
 - C) Une variation du VEMS > 12% sur deux spirométries
 - D) Une chute du VEMS < 20% au test à la Métacholine
 - E) Une chute du VEMS de 14% après deux bouffées de salbutamol
9. Concernant les bases du traitement de fond de l'asthme de l'enfant selon le GINA 2021, les propositions suivantes sont les suivantes :
- A) Les anti leucotriènes constituent une alternative thérapeutique de 1^{ère} intention chez le grand enfant
 - B) Un traitement par faible doses de corticoïdes et de formotérol en cas de gêne respiratoire est indiqué dans l'asthme modéré du grand enfant
 - C) L'association de corticoïdes avec une béta2 de longue durée d'action est préférable à l'augmentation des doses de corticoïdes**
 - D) La manipulation peut se faire selon une escalade ou une désescalade thérapeutique
 - E) La plus faible dose de corticothérapie permettant un contrôle optimal est retenue

10. Chez l'asthmatique jeune au cours d'une crise d'asthme modérée, on rencontre habituellement :
- A) Une ↓ de la CPT
 - B) Une ↓ des résistances des voies aériennes
 - C) **Une ↓ du VEMS**
 - D) Une hypercapnie
 - E) Une réversibilité du TVO
11. Une crise grave d'asthme se manifeste par :
- A) une bradycardie
 - B) **un silence à l'auscultation**
 - C) une bradypnée expiratoire
 - D) **une tachycardie > 125/mn**
 - E) une abondance de l'expectoration
12. Parmi les données suivantes, celle(s) qui permet (tent) d'éliminer le diagnostic de BPCO est(sont)
- A) VEMS post bronchodilatateur à 82% de la valeur prédite
 - B) Diffusion alvéolo-capillaire de CO(DLCO) à 85 % de la valeur prédite
 - C) Désaturation sévère à l'effort
 - D) **VEMS/CVF post bronchodilatateur à 75%**
 - E) Absence de tabagisme
13. La VNI dans les exacerbations aiguës de BPCO est indiquée dans la(les)situation(s) suivante(s) :
- A) Coma
 - B) **Exacerbation sévère hypercapnique**
 - C) Trouble de la vigilance
 - D) Épuisement respiratoire
 - E) **Acidose respiratoire**
14. le traitement pharmacologique qu'il faut prescrire en première intention chez un patient porteur de BPCO, ayant les caractéristique suivantes (dyspnée invalidante, notion d'hospitalisation pour une exacerbation sévère il y'a 3 mois et éosinophilie sanguine à 80 éléments/mm³) est :
- A) LAMA seul
 - B) LAMA, LABA et Azithromycine
 - C) LAMA, LABA et corticothérapie inhalée
 - D) **LAMA et LABA**
 - E) LABA et Corticothérapie inhalée
15. L'oxygénothérapie de longue durée chez les patients porteurs de BPCO :
- A) **Indiquée chez tout patient ayant une PaO₂ à l'état stable inférieur à 55 mmHg**
 - B) **Indiquée chez tout patient ayant une PaO₂ à l'état stable comprise entre 55 et 59 mmHg avec des signes de cœur pulmonaire chronique**
 - C) Indiquée chez les patients ayant une PaO₂ à l'état stable comprise entre 60 et 64 mmHg avec polyglobulie

- D) Doit avoir une durée minimale d'utilisation de 10 heures par jour
- E) Est contre indiquée chez les patients hypercapniques

16. L'infection par le HPV :

- A) Précède les lésions précancéreuses de quelques mois
- B) Est une maladie sexuellement transmise**
- C) Est rare
- D) Transitoire**
- E) Guérit spontanément**

17. Indiquez, parmi les suivantes, la ou les circonstance(s) qui vous impose(nt) le contrôle d'un frottis cervico-vaginal par un deuxième dans les plus brefs délais :

- A) Le caractère très inflammatoire du frottis.**
- B) Le prélèvement très hémorragique.**
- C) La présence d'une métaplasie malpighienne
- D) La découverte d'une lésion de dysplasie de haut grade
- E) L'absence de cellules endo-cervicales.**

18. Devant des céphalées récentes, des drapeaux rouges faisant évoquer une cause secondaire sont :

- A) Association à des signes systémiques et/ou extra- neurologiques**
- B) Le mode de début aigue**
- C) L'absence de signes de localisation
- D) Le contexte de grossesse ou post partum**
- E) Le contexte de néoplasie**

19. Les céphalées de tension se différencie de la migraine par :

- A) Leur localisation diffuse, parfois occipital**
- B) Leur association à des phénomènes dysautonomiques
- C) Leur retentissement sur la vie quotidienne
- D) Leur caractère continu**
- E) Leur intensité légère à modéré**

20. La névralgie de trijumeau secondaire se différencie de la classique par :

- A) Une atteinte fréquente du territoire V2 et V3 par rapport le V1
- B) Des décharges électriques plus prolongées dans le temps
- C) Une hypoesthésie faciale à l'examen neurologique**
- D) Un réflexe cornéen préservé
- E) Un fond continu de douleurs entre les accès**

21. Le traitement conservateur d'un cancer canalaire infiltrant du sein unilatéral T1N0M0 , RH- RE- HER2- SBR 3 chez une femme de 40 ans associe :

- A) Radiothérapie**
- B) Curage ganglionnaire**
- C) Chimiothérapie néoadjuvante**
- D) Chirurgie conservatrice : tumorectomie
- E) Hormonothérapie

22. Une masse classée ACR5 à la mammographie est

- A) Probablement bénigne
- B) Évocatrice de cancer**
- C) Un cancer prouvé histologiquement
- D) Sujette à une surveillance à court terme
- E. Sujette à un diagnostic histologique**

23. Chez un patient présentant une diarrhée chronique, le diagnostic d'un syndrome de l'intestin irritable est évoqué devant :

- A) Le caractère très variable de l'aspect des selles**
- B) Un amaigrissement récent
- C) Des douleurs abdominales aggravées par l'émission des selles
- D) L'évolution intermittente des symptômes**
- E) L'apparition récente des symptômes.

24. Chez un patient présentant une diarrhée chronique, le diagnostic d'une maladie de Crohn est évoqué devant :

- A) Le caractère sanglant de la diarrhée
- B) La présence d'une fistule anale**
- C) L'aspect segmentaire des lésions endoscopiques à la coloscopie.**
- D) Une iléite ulcérée**
- E) Une atteinte inflammatoire pancolique à la coloscopie

25. Pour évaluer la sévérité d'une hépatite virale aiguë on utilise le test suivant :

- A) Transaminases
- B) Bilirubine
- C) Gamma GT
- D) Phosphatases alcalines
- E) Taux de prothrombine.**

26. Concernant l'hépatite virale B :

- A) Le risque de transmission mère-enfant est négligeable
- B) Elle est souvent asymptomatique de découverte fortuite**
- C) Elle peut donner un tableau d'hépatite aiguë grave**
- D) N'évolue pas vers la chronicité.
- E) Elle se transmet par voie sanguine**

27. La résection d'un mètre de l'iléon distal peut entraîner une malabsorption :

- A) du fer
- B) du calcium
- C) des acides biliaires**
- D) de la vitamine B12**
- E) des acides aminés

28. L'absorption intestinale du glucose :

- A) est similaire à celle du galactose
- B) se produit au niveau de l'intestin grêle proximal
- C) nécessite la formation de micelles
- D) fait intervenir le transporteur GLUT2 du côté luminal
- E) est totale

29. Devant une douleur thoracique, les signes évocateurs d'une origine pleurale sont :

- A) L'amélioration en position couchée
- B) Le caractère constrictif de la douleur
- C) La variation de l'intensité de la douleur avec les mouvements respiratoires
- D) Le caractère migrateur de la douleur
- E) L'aggravation des douleurs à la toux

30. Concernant les biomarqueurs en cas de douleur thoracique :

- A) Les D-Dimères négatifs éliminent le diagnostic d'embolie pulmonaire
- B) Les troponines ont un intérêt pronostique dans la suspicion d'embolie pulmonaire.
- C) Les troponines ont un intérêt pronostic en cas de syndrome coronarien aigu
- D) Les D-Dimères peuvent être utiles pour éliminer une dissection de l'aorte
- E) En cas de négativité initiale des troponines US, le dosage doit être refait après 3 heures

31. Le frottement péricardique:

- A) Est superficiel
- B) Disparaît en apnée
- C) Irradie vers l'aisselle
- D) Est fugace
- E) Est raueux

32. L'obsession est :

- A) Une idée délirante.
- B) Une sorte d'hallucination.
- C) Associée à la dépression
- D) L'intrusion dans la pensée d'une idée pathologique.
- E) Accompagnée d'un sentiment de plaisir

33. La crainte angoissante d'être amené de façon irrésistible à commettre un acte immoral est :

- A) Une obsession dépressive.
- B) Une phobie simple.

- C) **Une obsession impulsive.**
D) Une obsession idéative.
E) Une agoraphobie.
34. **Le syndrome psycho traumatique (PTSD) peut associer les signes suivants**
A) **Des troubles du sommeil**
B) Une hyperphagie
C) **Une reviviscence de l'évènement traumatisant (flash back).**
D) **Une agitation psychomotrice**
E) Un délire de persécution
35. **Concernant l'imagerie d'échinococcose kystique simple :**
A) **L'échographie thoracique est pratiquée en cas de kyste périphérique.**
B) Le scanner thoracique est la première exploration à demander.
C) L'hydatide prend le contraste après injection du produit de contraste au scanner thoracique.
D) **Il s'agit souvent d'une opacité ronde à la radiographie thoracique.**
E) L'échographie thoracique donne un aspect de cône d'ombre postérieur
36. **La vomique hydatique:**
A) **Est un signe pathognomonique du KHP**
B) Est associée à une lymphocytose à NFS
C) Peut être responsable d'un tableau de détresse respiratoire aigue
D) Est en rapport avec un kyste hydatique sain
E) **Peut être associée à un choc anaphylactique**
37. **Le traitement de l'échinococcose kystique repose sur:**
A) **La thoracotomie ou la vidéothoroscopie selon la technique de Barrett pour le KHP central**
B) **La kystectomie totale pour les kystes périphériques**
C) La thoracotomie selon la technique d'Ugon pour les gros kystes
D) La lobectomie en cas de kyste hydatique rompu dans la plèvre
E) **Le traitement du kyste primitif et la décortication pleurale en cas d'ouverture dans la plèvre**
38. **L'angiotensine II stimule la sécrétion :**
A) De la rénine
B) **D'aldostérone**
C) Du FAN
D) **D'ADH**
E) De noradrénaline
39. **Un risque très élevé selon GLOBORISK est défini par :**
A) **Un diabète de type 2 associé à une dyslipidémie**
B) Un score > 10%
C) **Un diabète de type 2 avec atteinte d'organe cible**
D) **Un AVC**

E) Une maladie coronaire

40. Les IEC peuvent être responsables des effets secondaires suivants :

- A) Une insuffisance rénale aigue**
- B) Un œdème malléolaire
- C) Une hypokaliémie
- D) Une toux sèche**
- E) Un angioedème**

41. L'anatomie des voies biliaires est caractérisée par :

- A) Un conduit cholédoque mesurant 4 mm de diamètre
- B) Des canalicules biliaires péri-lobulaires ayant les mêmes trajets que les branches terminales de la veine hépatique
- C) Des canaux hépatiques droit et gauche incluses dans une gaine fibreuse**
- D) Un conduit hépatique droit constitué de la réunion des canaux segmentaires des segments II, III et IV
- E) Une circulation de la bile du foie vers le deuxième duodénum**

42. Les conséquences hépatiques et plasmatiques de la cholestase sont :

- A) Des urines mousseuses**
- B) Une ostéodystrophie
- C) Une cirrhose biliaire secondaire**
- D) Un prurit secondaire à l'accumulation de la bilirubine
- E) Une accumulation du cuivre en intra-hépatocytaire**

43. Dans la cholestase extra-hépatique, la dilatation des voies biliaires peut manquer dans les cas suivants :

- A) Une obstruction biliaire récente**
- B) Des voies biliaires à paroi scléreuse**
- C) Cholangite biliaire primitive avec une fibrose légère
- D) Hépatite virale B
- E) Une cirrhose**

44. Une paracentèse est indiquée devant :

- A) Une otite moyenne aigue chez un nourrisson de 2 mois**
- B) Un Syndrome otite-conjonctivite**
- C) Une otite moyenne aigue collectée hyperalgique
- D) Une otite moyenne aigue compliquée de paralysie faciale périphérique**
- E) Une Otite moyenne aigue chez un enfant immunodéprimé**

45. La phase initiale de la bronchite virale typique associe :

- A) Coryza et odynophagie**
- B) Toux sèche quinteuse, rauque**

C) **Expectoration purulente**

D) Fièvre modérée (38–38,5 °C)

E) douleur basi thoracique

46. L'antibiothérapie probabiliste à indiquer chez un patient porteur de PABC nécessitant la réanimation est :

A) Association teicoplanine et macrolides

B) Association cephalosporine 3^{ème} génération et macrolide

C) Amoxicilline - acide clavunamique

D) Association cephalosporine 3^{ème} génération et levofloxacin

E) Association levofloxacin et macrolides

47. Les indications de l'hospitalisation en réanimation chez un patient porteur de PABC sont :

A) PaO₂ :70mmHg

B) PaO₂/FiO₂ < 250 mm Hg

C) CIVD

D) Atteinte multilobaire

E) PAB chez un patient porteur de BPCO

48. Devant la survenue d'une phlébite chez un jeune de 20 ans, les étiologies à évoquer en premier lieu sont :

A) Un lupus

B) Un cancer

C) Une thrombophilie

D) Une maladie de Behcet

E) Un syndrome des antiphospholipides

49. Les signes électrocardiographiques en faveur d'une embolie pulmonaire sont :

A) Un axe droit

B) Un aspect S en D1 et Q en D3

C) Une Tachycardie

D) Un microvoltage

E) Un bloc de branche droit

50. Les signes radiologiques en faveur du diagnostic d'embolie pulmonaire sont :

A) Une ascension diaphragmatique

B) Une hyper-clarté parenchymateuse

C) Une déviation trachéale

D) Des atélectasies en bandes

E) Un épanchement pleural

51. La péritonite aiguë secondaire est souvent causée par :

A) une rupture d'organe creux entraînant une contamination du péritoine.

B) une infection spontanée dans un contexte d'ascite.

C) une inflammation chronique d'étiologie inconnue.

D) une ischémie mésentérique sans perforation.

E) une maladie auto-immune du péritoine.

52. Quelle sont les deux causes les plus fréquentes de péritonite aiguë secondaire ?

- A) **péritonite d'origine appendiculaire.**
- B) traumatisme abdominal ouvert.
- C) **perforation d'ulcère gastroduodénal.**
- D) rupture d'un kyste ovarien.
- E) perforation d'une tumeur du côlon.

53. Un homme de 50 ans, aux antécédents de diverticulite sigmoïdienne traité médicalement, se présente avec une douleur abdominale aiguë, de la fièvre à 39°C et des frissons. À l'examen, il y a une défense abdominale généralisée. Le scanner abdominal montre une perforation sigmoïdienne avec épanchement gazeux et liquidien péritonéal.

Quelle est la prise en charge optimale ?

- A) antibiothérapie seule.
- B) drainage percutané de l'épanchement.
- C) colectomie segmentaire avec rétablissement de la continuité.
- D) surveillance sous traitement médical.
- E) **colectomie segmentaire avec colostomie à la hartmann.**

54. Parmi les propositions suivantes, qu'elles sont celles qui peuvent cadrer avec une péritonite par perforation ulcéreuse ?

- A) **Le siège initial de la douleur est épigastrique**
- B) L'amaigrissement récent
- C) Le début des symptômes est progressif
- D) Les vomissements sont de type bilieux
- E) **La douleur abdominale en coup de poignard**

55. Chez un malade déprimé, parmi les éléments du risque suicidaire, on retient :

- A) Le sexe féminin
- B) **La sévérité de la dépression avec désespoir**
- C) L'importance du ralentissement moteur
- D) **La préméditation de l'acte**
- E) **L'isolement social**

56. La gravité de l'état dépressif s'évalue par :

- A) **La présence d'idées délirantes**
- B) L'importance des facteurs de stress
- C) **L'importance du ralentissement moteur**
- D) **L'absence d'amélioration de l'humeur par la réassurance**
- E) **Le risque suicidaire**

57. Parmi les symptômes suivants, lesquels sont typiques d'un accès maniaque :

- A) **Excitation psychique**
- B) Perplexité anxieuse
- C) Hallucinations auditives
- D) **Excitation motrice**
- E) **Excitation instinctuelle**

58. La miliaire tuberculeuse :

- A) Est une forme pseudo-tumorale de la tuberculose
- B) **Est une urgence thérapeutique**
- C) **Est caractérisée sur le plan radiologique par un syndrome interstitiel micronodulaire**
- D) Ne nécessite pas une déclaration
- E) **Est plus fréquente chez le patient infecté par le VIH**

59. Concernant le traitement de la tuberculose pulmonaire :

- A) L'efficacité s'apprécie par la clinique et la radiologie
- B) **La combinaison fixe est l'actuelle tendance du traitement antituberculeux**
- C) **L'éducation sanitaire est primordiale dans l'observance du traitement**
- D) La guérison est obtenue au 5^{ème} mois si les recherches de BK sont négatives
- E) La supervision directe à la vue est indispensable durant la phase intensive du traitement seulement

60. Le traitement recommandé de la maladie ulcéreuse gastro-duodenale non compliquée:

- A) Est basé sur des antibiotiques seuls
- B) **Associe une antibiothérapie à un traitement anti-sécrétoire à base d'IPP**
- C) Permet l'éradication de HP dans plus de 90% des cas
- D) **Est d'une durée de 7 jours**
- E) Est Suivi systématiquement d'un traitement d'entretien à base d'IPP

61. Concernant le syndrome ulcéreux typique, les propositions vraies sont:

- A) les douleurs sont exacerbées par la prise alimentaire
- B) **Les douleurs épigastriques sont typiquement à type de crampe**
- C) Est souvent associé à un amaigrissement important
- D) **Est souvent associé à une Constipation au moment des poussées.**
- E) **Les épigastralgies sont volontiers périodiques dans l'année**

62. En cas d'ulcère bulbaire résistant au traitement médical associé à une diarrhée chronique, vous évoquez le diagnostic suivant:

- A) Cancer du colon
- B) Colopathie fonctionnelle
- C) Diverticulose sigmoïdienne

- D) Syndrome carcinoïde
- E) **Gastrinome**

63. La sécrétion acide gastrique augmente sous l'effet de :

- A) **l'histamine**
- B) la sécrétine
- C) la somatostatine
- D) les prostaglandines
- E) **l'acétylcholine**

64. La sécrétion de gastrine augmente en réponse à :

- A) **l'acétylcholine**
- B) la sécrétine
- C) **l'arrivée d'aliments riches en protéines**
- D) l'histamine
- E) **la distension de l'estomac**

65. La sécrétion acide gastrique est inhibée par :

- A) l'histamine
- B) la gastrine
- C) **la sécrétine**
- D) **la somatostatine**
- E) **la cholécystokinine**

I- Partie II : CCQCM

Cette partie comprend cas cliniques. Les réponses doivent être inscrites sur la grille réservée aux CCQCM

Cas clinique 1 :

Patient âgé de 45 ans, suivi pour une insuffisance rénale chronique sous hémodialyse, consulte les urgences pour une hémorragie digestive extériorisée sous forme d'hématémèse. La TA : 75/45 mmHg, la Fc : 125b/min, ictère cutanéomuqueux.

1. Les éléments de gravité de cette hémorragie digestive sont :

- A) L'âge du patient
- B) **Les constantes hémodynamiques**
- C) La circonstance de découverte de l'hémorragie digestive
- D) La présence d'un ictère cutanéomuqueux
- E) **Les antécédents du patient**

2. Le premier examen complémentaire à demander chez ce patient :

- A) Un angioscanner coelio-mésentérique
- B) Une coloscopie totale
- C) Une scintigraphie au GR-Tech

- D) Un transit œsogastroduodénal
- E) **Une fibroscopie digestive haute**

3. Les deux étiologies les plus probables à cette hémorragie digestive sont :

- A) Une tumeur gastrique
- B) **La maladie ulcéreuse gastro duodénale**
- C) Les ulcérations cardiales (syndrome de Mallory Weiss)
- D) Une œsophagite sévère
- E) **Les varices œsophagiennes**

4. Les mesures de réanimations ont été entamées pour ce patient, une altération sévère de l'état de conscience s'est installée rapidement, le score de Glasgow est à 10/15

Cette évolution défavorable serait secondaire à :

- A) **La persistance de l'hémorragie**
- B) **L'aggravation de l'état hémodynamique**
- C) **Un hyper ammoniémie**
- D) **La surcharge pulmonaire (œdème aigue de poumon)**
- E) Une élévation du chiffre de créatinine

Cas clinique 2 :

Patient âgé de 77 ans consulte pour douleur de la fosse iliaque droite évoluant depuis deux jours sans troubles de transit.

A l'examen : BMI : 30 Kg/m² T 37,8 Sensibilité de la fosse iliaque droite

Toucher rectal : Douleur latéralisée à droite

Bandelette urinaire : leucocyturie négative, créatinine 55 umol/l

5. **Quels sont les diagnostics à évoquer en premier lieu :**

- A) Une gastro-entérite
- B) Une maladie de crohn
- C) **Un cancer du cœcum**
- D) Une infection urinaire
- E) **Une appendicite aigue**

6. **Quel est l'examen radiologique à demander ?**

- A) Une IRM abdominale
- B) **Un scanner abdominal**
- C) Une radiographie de thorax
- D) Une échographie abdominale
- E) Une scintigraphie osseuse

L'examen radiologique a objectivé deux reins d'aspects normaux, absence d'épaississement grélique, un appendice de 9 mm de diamètre avec une infiltration de la graisse appendiculaire et un épaississement coecal réactionnel.

7. Quel est le diagnostic retenu :

- A) Une gastro-entérite
- B) Un cancer du cœcum**
- C) Une infection urinaire
- D) Une maladie de crohn
- E) Une appendicite aiguë

8. La conduite à tenir thérapeutique chez ce patient est :

- A) Une antibiothérapie intra veineuse
- B) Une résection iléo-caecale
- C) Un drainage radiologique
- D) Une hémi colectomie droite
- E) Une appendicectomie**

Cas clinique 3 :

Kinza, âgé de 20 mois, consulte pour toux récurrente grasse trainante depuis l'âge de 5 mois. Sa période néonatale était sans incidents respiratoires. Par ailleurs, les parents rapportent des épisodes de dyspnées sifflantes améliorés par nébulisations de Béta2mimétiques ; le dernier épisode remonte à 2 mois.

Sa mère est asthmatique et sa sœur de 4 ans était suivie pour une dermatite atopique. Le père est sans antécédents pathologiques, cependant, il est tabagique.

L'examen physique était normal en dehors d'un signe de Dennie Morgan. Vous retenez le diagnostic d'asthme du nourrisson.

9. Les signes cliniques en faveur du diagnostic de l'asthme du nourrisson chez Kinza sont :

- A) Le tabagisme paternel
- B) La dermatite atopique chez la sœur**
- C) Le signe de Dennie Morgan**
- D) L'asthme maternel
- E) La toux grasse récurrente et trainante**

10. Les explorations allergologiques que vous recommandez pour kinza sont :

- A) Le dosage des IgE totales

- B) Les prick tests
- C) La numération formule sanguine
- D) La spirométrie
- E) Le dosage des IgE spécifiques respiratoires

11. Le traitement de fond que vous prescriviez pour Kinza peut consister en :

- A) Une fluticasone inhalée
- B) Une B2 de courte durée d'action
- C) Un anti cholinergique inhalé
- D) Un anti leucotriène
- E) Un budésonide nébulisé

Cas clinique 4

Une femme âgée de 35 ans, connue asthmatique dès l'âge de 10 ans, sous Salbutamol à la demande, consulte les urgences pour une dyspnée sifflante d'installation rapide. A l'interrogatoire, la patiente rapporte l'installation depuis trois semaines de gênes respiratoires fréquentes nécessitant l'usage quotidien de bronchodilatateur à la demande, une réduction de l'activité quotidienne et des réveils nocturnes fréquents. La surveillance du débit expiratoire de pointe à domicile durant les trois dernières semaines a objectivé une variation quotidienne moyenne de 12%.

A l'examen on note des difficultés à la parole, fréquence respiratoire à 36 cycles/mn, fréquence cardiaque à 140 battements/mn, saturation à l'air ambiant à 87%, présence de distension thoracique, un tympanisme bilatéral à la percussion et à l'auscultation pulmonaire on note des râles sibilants aux 2 champs pulmonaires, le débit expiratoire de pointe (DEP) est à 100 L/mn (22% de la valeur théorique).

12. Les éléments orientant vers la sévérité de l'exacerbation d'asthme sont :

- A) La distension thoracique
- B) Le débit expiratoire de pointe à 100 L/mn
- C) Le tympanisme bilatéral à la percussion
- D) La fréquence respiratoire à 36 cycles/mn
- E) Les difficultés à la parole

13. Le traitement de 1ère intention de cette exacerbation comporte :

- A) Une oxygénothérapie
- B) Une ventilation non invasive
- C) Une ventilation mécanique
- D) Des nébulisations des bronchodilatateurs
- E) Une corticothérapie par voie générale

14. D'après les données de l'anamnèse, les critères de mauvais contrôle de l'asthme chez cette patiente sont :

- A) L'installation rapide de la dyspnée
- B) Les réveils nocturnes fréquents
- C) La variation quotidienne moyenne du DEP de 12%

- D) L'usage quotidien de bronchodilatateur à la demande
- E) Le retentissement sur l'activité quotidienne

15. Après traitement complet de l'exacerbation aiguë, le traitement de fond de 1ère intention de l'asthme chez cette patiente doit comporter :

- A) Une association corticostéroïdes inhalés faible dose – Formotérol à la demande
- B) Un LABA en traitement continu seul
- C) Une corticothérapie orale en continu faible dose
- D) Une association corticostéroïdes inhalés – LABA en traitement continu**
- E) Un anti-leucotrienne en traitement continu seul

Cas clinique 5

Homme âgé de 46 ans Fumeur à 15 PA sévère, sans antécédents. Consulte pour une toux apparue depuis plusieurs mois qui le gêne de plus en plus. Pas d'altération de l'état général. Examen physique est normal

Endoscopie bronchique: lésion bourgeonnante de la bronche lobaire inférieure droite. Biopsie bronchique: adénocarcinome pulmonaire primitif.

Scanner thoracoabdominopelvien: Tumeur pulmonaire du lobe inférieure droit mesurée à 65 mm de plus grand diamètre. Adénopathie hilare droite (11R), sous carénaire (7) et para trachéale droite (4R et 2R)

IRM cérébrale normale

Scintigraphie osseuse : Pas de métastases osseuses

Exploration fonctionnelle respiratoire normale

16. Selon la classification TNM, la tumeur est classée :

- A) T3N2aM0
- B) T4N3M0
- C) T3N2bM0**
- D) T4N2aM0
- E) T3N3M0

17. Quel est le stade de l'ADK diagnostiqué chez ce Mr ?

- A) IIB
- B) B- IIIA
- C) C-IIIB**
- D) D- IIIC
- E) E- IVA

18. Quel traitement proposez-vous pour ce patient?

- A) Radio-chimiothérapie séquentielle
- B) Radio-chimiothérapie concomitante à visée curative**
- C) Chimiothérapie d'induction suivie de chirurgie à visée curative
- D) Radio-chimiothérapie concomitante puis chirurgie
- E) Chirurgie suivie d'une chimiothérapie

Cas clinique 6 :

Patient âgé de 15 ans, originaire de Gafsa, sans antécédents pathologiques notables consulte pour une épistaxis récidivante gauche associée à une voix nasonnée évoluant depuis une année. Le patient rapporte récemment une hypoacousie avec autophonie récentes. L'examen physique montre un magma d'adénopathies spinales hautes gauches de 6 cm et un trismus.

Une endoscopie nasale avec biopsie du cavum ont conclu à un UCNT du cavum.

19. Les signes cliniques qui plaident en faveur du diagnostic chez ce patient sont :

- A) L'origine géographique
- B) La voix nasonnée**
- C) L'autophonie**
- D) Le trismus**
- E) L'épistaxis unilatérale récidivante**

Une TDM du cavum réalisée a montré un processus tumoral comblant le nasopharynx s'étendant à l'oropharynx, infiltrant l'espace para pharyngé gauche, le muscle ptérygoïdien latéral et lysant l'apophyse ptérygoïde homolatérale, avec présence d'adénopathies rétro pharyngées bilatérales.

20. Ce bilan d'extension doit être complété par :

- A) Une IRM du cavum**
- B) Une scintigraphie osseuse**
- C) Une échographie cervicale
- D) Une TDM thoraco abdomino pelvienne**
- E) Une pan endoscopie

Sachant que le bilan d'extension à distance que vous avez demandé n'a pas montré des métastases secondaires.

21. La tumeur sera classée selon la classification TNM de l'UICC 2017 en :

- A) T4N1M0
- B) T4N2M0
- C) T2N2M0
- D) T3N2M0
- E) T3N1M0**

22. La prise en charge que vous préconisez chez ce patient comporte :

- A) Une évaluation de l'état nutritionnel**
- B) Une consultation d'oncofertilité**

- C) Une radio chimiothérapie concomitante
- D) La confection de gouttière porte gel fluoré**
- E) Une Chimiothérapie néoadjuvante suivie de radio chimiothérapie concomitante

Cas clinique 7

Une patiente âgée de 68 ans connue porteuse d'un adénocarcinome rectale diagnostiqué à l'occasion d'un syndrome occlusif spontanément résolutif

23. Le bilan d'extension de cette tumeur doit comporter :

- A) Un uroscanner
- B) **Une TDM Thoraco-abdominopelvienne**
- C) **Le dosage des marqueurs tumoraux**
- D) Une scintigraphie osseuse
- E) **Une IRM pelvienne**

Au terme du bilan demandé la tumeur est jugée résécable. En sachant que la tumeur est située à 12 cm de la marge anale, elle est T3 N0M0

24. Que proposez-vous pour cette patiente ?

- A) Une amputation abdomino-pelvienne
- B) Une résection locale par voie trans-annale
- C) Une résection segmentaire basse
- D) Une résection antérieure et une anastomose colorectale**
- E) Une résection rectale élargie à la cloison recto-vaginale

25. Les éléments suivants sont considérés de mauvais pronostic :

- A) La résection de 15 ganglions lymphatiques examinés sur la pièce opératoire
- B) L'absence d'un traitement néoadjuvant
- C) **Le mode de révélation de la tumeur rectale**
- D) Le stade T3 aux explorations morphologiques
- E) L'âge du patient

26. La surveillance pendant les deux premières années suivant l'acte chirurgicale doit comprendre :

- A) Un examen clinique mensuel
- B) Une TDM pelvienne chaque 6 mois
- C) Une première coloscopie totale à 6 mois
- D) Une échographie chaque 3 mois**
- E) Un dosage des marqueurs tumoraux chaque 3 mois**

Cas clinique 8 :

Mme X, 40 ans, non ménopausée, consulte pour un nodule du quadrant supéro-externe du sein de 1 cm, sans adénopathies axillaires

27. **l'examen complémentaire indispensable pour affirmer le diagnostic de malignité est :**

- A) L'échographie mammaire
- B) BLa mammographie
- C) La cytoponction
- D) La biopsie avec examen anatomo-pathologique**
- E) L'IRM mammaire

Le diagnostic d'un carcinome canalaire infiltrant est confirmé. Le bilan d'extension est négatif.

28. **La classification TNM de ce nodule est :**

- A) T1 N1 M0
- B) T2 N1 M0
- C) T1 N0 M0**
- D) T4 N1 M0

29. **Votre attitude thérapeutique comportera :**

- A) Intervention PATEY
- B) Irradiation exclusive
- C) Mastectomie + chimiothérapie
- D) Tumorectomie + curage ganglionnaire suivi d'irradiation**
- E) Mastectomie suivie d'irradiation

Cas clinique 9 :

Homme de 32 ans, infirmier au bloc opératoire d'orthopédie, consulte les urgences pour un ictère d'allure cholestatique et asthénie intense évoluant depuis 3 jours avec apparition d'une confusion mentale depuis 6 heures. Cette symptomatologie était précédée, 7 jours avant, par des arthralgies et des myalgies diffuses motivant la prise de paracétamol 3g/j pendant 3 jours. Le bilan biologique a montré : ALAT= 2800 UI, ASAT = 2200 UI, BT= 120 μ mol/L, BD= 95 μ mol/L, PAL = 420 UI, GGT= 160 UI, TP = 42 %, Hb= 10,6 g/dL, VGM= 85, GB= 3500/mm³, Plaquettes = 260 000/mm³.

Vous évoquez un tableau d'hépatite aigue virale.

30. Les arguments en faveur d'une hépatite virale chez ce patient sont :

- A) Age jeune
- B) Notion d'arthralgies et de myalgies précédant l'ictère**
- C) Ictère d'installation rapide
- D) Profession du patient**
- E) Asthénie intense

31. Les éléments qui justifient l'hospitalisation immédiate de ce patient sont :

- A) Asthénie intense
- B) Confusion mentale**
- C) Cytolyse importante à 70N
- D) Taux des GB à 3500/mm³
- E) TP à 42 %**

32. Parmi les sérologies virales demandées, la sérologie B a montré les résultats suivants : AgHBs (+), IgM anti-HBc (+), IgG anti-HBc (+), AgHBe (+), Ac anti-HBe (-).

Le paramètre sérologique qui vous permet de retenir une hépatite aigue virale B est :

- A) AgHBs (+)
- B) IgG anti-HBc (+)
- C) Ag HBe (+)
- D) IgM anti-HBc (+)**
- E) Ac anti-HBe (-)

33. Vous proposez en urgence chez ce patient le traitement suivant :

- A) Sofosbuvir + Velpatasvir
- B) Entecavir**
- C) Ribavirine
- D) Interféron pégylé
- E) Traitement symptomatique sans antiviraux

Cas clinique 10

Monsieur C., 45 ans, sans antécédents psychiatriques, est hospitalisé pour des troubles du comportement rapidement installés depuis 36 heures. Il a du mal à tenir en place, parle beaucoup, dort peu. Il semble par moments très perplexe, comprenant mal les propos du médecin : il se trompe sur la date, se croit à son travail, oublie au fur et à mesure ce qu'on lui dit paraît légèrement somnoler par instants, à d'autres, semble très inquiet, "où suis-je ? Qui êtes vous ?", demande-t il aux personnes présentes. Brusquement, il jette un objet dans un coin de la pièce comme pour se défendre d'une vision terrifiante.

L'examen clinique est normal, mis à part une fièvre à 38,5 degrés et des signes de déshydratation (soif, langue sèche, ébauche de pli cutané).

L'examen neurologique est normal

34. Parmi la liste de symptômes suivants, quel est celui ou quels sont ceux qu'on retrouve dans cette observation ?

- A) Désorganisation de la pensée
- B) Automatisme mental
- C) Perplexité anxieuse**
- D) Labilité thymique
- E) Désorientation temporo-spatiale**

35. Quel(s) diagnostic(s) peut-on évoquer en priorité ?

- A) Accès maniaque
- B) Schizophrénie
- C) Dépression délirante
- D) Délire paranoïaque
- E) Confusion mentale**

36. Quelle est la ou quelles sont les mesures thérapeutiques qui s'imposent dans l'immédiat ?

- A) Hospitalisation**
- B) électro-convulsivo thérapie (ECT)
- C) Contention Physique
- D) Prescription de benzodiazépines**
- E) Réhydratation**

Cas clinique 11

Patient âgé de 45 ans, suivi pour une insuffisance rénale chronique sous hémodialyse, consulte les urgences pour une hémorragie digestive extériorisée sous forme d'hématémèse. La TA :75/45 mmhg, la Fc :125b/min, ictère cutanéomuqueux.

37. Les éléments de gravité de cette hémorragie digestive sont :

- A) L'âge du patient
- B) Les constantes hémodynamiques**
- C) Les antécédents du patient**
- D) La circonstance de découverte de l'hémorragie digestive
- E) La présence d'un ictère cutanéomuqueux

38. Le premier examen complémentaire à demander chez ce patient :

- A) Un angioscanner coelio-mésentérique
- B) Une scintigraphie au GR-Tech
- C) Une fibroscopie digestive haute**
- D) Un transit œsogastroduodénal
- E) Une coloscopie totale

39. Les deux étiologies les plus probables à cette hémorragie digestive sont :

- A) Les varices œsophagiennes
- B) Les ulcérations cardiales (syndrome de Mallory Weiss)
- C) Une tumeur gastrique
- D) La maladie ulcéreuse gastro duodénale**
- E) Une œsophagite sévère

40. Les mesures de réanimations ont été entamées pour ce patient, une altération sévère de l'état de conscience s'est installée rapidement, le score de Glasgow est à 10/15

Cette évolution défavorable serait secondaire à :

- A) La persistance de l'hémorragie
- B) Une élévation du chiffre de créatinine
- C) La surcharge pulmonaire (œdème aigue de poumon)**
- D) Un hyper ammoniémie**
- E) L'aggravation de l'état hémodynamique

Cas clinique 12 :

Patient M.A., âgé de 35 ans, sans antécédents particuliers, admis pour un tableau clinique d'angiocholite avec : Fièvre à 39 °C, Douleur de l'hypochondre droit, Ictère évoluant depuis 3 jours.

À l'examen : État général conservé, TA = 12/7, Abdomen souple, sensible au niveau de l'hypochondre droit.

L'échographie abdominale a montré une lésion kystique du segment IV, mesurant 8 cm de grand axe, à aspect multivésiculaire, associée à une dilatation de la VBP (12 mm) et à un contenu hétérogène.

Vous évoquez une angiocholite hydatique.

41. Le kyste hydatique représente :

- A) La première cause d'angiocholite aiguë en Tunisie
- B) La deuxième cause d'angiocholite aiguë en Tunisie**
- C) Peut s'associer à une lithiase vésiculaire**
- D) Intéresse surtout les sujets âgés de plus de 60 ans
- E) Atteint l'homme et la femme sans prédominance de sexe**

42. Quel est le mécanisme pathogénique de cette angiocholite ?

- A) Dissémination par voie lymphatique
- B) Fissuration du kyste dans les voies biliaires intra-hépatiques

- C) Large fistule bilio-kystique avec passage de matériel hydatique dans la voie biliaire
- D) Compression des voies biliaires par le kyste
- E) Reflux cholangio-veineux à l'origine d'une bactériémie

43. Dans le bilan pré-thérapeutique, quels autres examens complémentaires demandez-vous ?

- A) Bilan d'hémostase
- B) Bili-IRM
- C) Radiographie thoracique
- D) TDM abdominale
- E) Bilan hépatique

44. Dans le tableau clinique présenté, aucun signe de gravité n'a été noté. Quelle démarche thérapeutique proposez-vous ?

- A) Antibiothérapie + sphinctérotomie endoscopique
- B) Antibiothérapie seule
- C) Antibiothérapie + chirurgie 24 à 48 h après l'admission
- D) Antibiothérapie + chirurgie en urgence
- E) Antibiothérapie + traitement antiparasitaire sans autre méthode thérapeutique

Cas clinique 13

Un nouveau-né âgé de 7 jours est ramené par ses parents aux urgences pédiatriques pour ictère cutanéomuqueux constaté depuis J3 de vie. A l'interrogatoire, les urines sont foncées et les selles décolorées.

45. Quel est votre premier diagnostic?

- A) Lithiase biliaire
- B) Déficit en alpha 1 antitrypsine
- C) Mucoviscidose
- D) Atrésie des voies biliaires
- E) Syndrome d'Alagille

46. L'examen d'imagerie, de première intention, que vous demandez sera:

- A) Abdomen sans préparation
- B) Echographie cardiaque
- C) Echographie abdominale
- D) Cholangiographie transhépatique
- E) Radiographie de thorax

47. Le bilan sanguin montre ces anomalies:

- A) des Gamma glutamyl transpeptidases élevées**
- B) Hyperbilirubinémie à prédominance conjuguée**
- C) Hyperbilirubinémie à prédominance libre
- D) des Gamma glutamyl transpeptidases basses
- E) Un taux bas des phosphatases alcalines

48. Le traitement de cette pathologie repose sur:

- A) Antipyrétiques
- B) Vitaminothérapie ADEK**
- C) Hépatopertoentérostomie**
- D) Transfusion sanguine
- E) Acide ursodésoxycholique**

Cas clinique 14

Mme H. 48 ans, est hospitalisée dans le service pour des troubles du comportement.

Mme H. raconte que ses voisins l'observent et veulent lui faire du mal. Elle dit aussi qu'elle perçoit des ondes qui lui sont transmises. Elle a appelé la police à plusieurs reprises pour « nuisances phoniques ».

Tout son discours est heurté, chaotique, avec des sauts du coq à l'âne, des réponses à côté et une impression de flou, d'hermétisme et d'ambivalence.

A certains moments, la patiente s'arrête de parler, semble ailleurs, puis reprend son monologue.

Depuis 20 ans, elle est suivie en ambulatoire et est traitée par des antipsychotiques.

49. La patiente présente :

- A) Un syndrome dissociatif**
- B) Un automatisme mental
- C) Un état hallucinatoire**
- D) Un syndrome d'influence
- E) Un délire de persécution

50. Le diagnostic le plus probable est :

- A) Une bouffée délirante aiguë
- B) Une psychose hallucinatoire chronique**
- C) Une schizophrénie paranoïde
- D) Une démence précoce

E) Une paranoïa

51. Vous allez instaurer ou restaurez le traitement suivant :

- A) Antipsychotique sédatif à forte dose
- B) Antidépresseur à faible dose
- C) Antidépresseur à forte dose
- D) Antipsychotique atypique à forte dose**
- E) Antipsychotique désinhibiteur à faible dose

52. Votre surveillance clinique va porter sur :

- A) L'apparition d'un syndrome dépressif
- B) L'apparition d'une hypotension orthostatique**
- C) L'apparition de tremblements
- D) L'apparition d'un goitre
- E) La diminution du délire**

Cas clinique 15

Une femme âgée de 45 ans est hospitalisée pour prise en charge d'une tuberculose pulmonaire commune. Son poids est 65 Kg.

54. Le bilan pré thérapeutique doit comporter :

- A) **Un test d'acétylation**
- B) **Un champ visuel**
- C) Un dosage des ASAT et ALAT
- D) Un test au Quantiferon
- E) **Un bilan rénal**

55. Le bilan est normal, le schéma thérapeutique de la phase d'attaque est le suivant :

- A) 4 comprimés de HRE pendant 9 mois
- B) 3 comprimés de HRZE pendant 2 mois
- C) 4 comprimés de HRZE pendant 2 mois**
- D) 3 comprimés de HR pendant 4 mois
- E) 4 comprimés de HRZE pendant 4 mois

A J7 du traitement, la patiente a présenté un prurit généralisé avec des lésions cutanées type urticaire

56. Les antituberculeux les plus pourvoyeurs de cette réaction allergique sont:

- A) Rifadine
- B) Ethambutol
- C) **Pyrazinamide**
- D) Tous les antituberculeux
- E) INH

57. La conduite serait:

- A) **Arrêter le traitement antituberculeux jusqu'à disparition des lésions cutanées**
- B) Arrêter la Rifadine et l'INH et poursuivre les autres antituberculeux
- C) **Traitement antihistaminique**
- D) Arrêter l'INH et poursuivre les autres antituberculeux
- E) Arrêter la Pyrazinamide et poursuivre les autres Antituberculeux

Cas clinique 16

Mr AB âgé de 60 ans, aux antécédents d'HTA sous captopril et lombosciatique mis sous piroxicam et paracétamol depuis une semaine, Consulte aux urgences pour hématomèse et méléna survenant depuis 2h . L'examen aux urgences trouve un malade agité , pale , TAS: 80mmhg ,extrémités froides . Le bilan biologique d'urgence trouve Hb: 5.2g/dl –plaquettes :225000/mm³ –TP : 98% -urée : 11mmol/l et créatinine : 128μmol/l –ionogramme sanguin correcte –bilan hépatique correcte . L'origine ulcéreuse de cette hémorragie a été présumée .

58. la conduite à tenir en urgence chez ce patient serait :

- A) acheminer directement le malade à la salle d'endoscopie
- B) **fibroscopie digestive haute après stabilisation du malade**
- C) **réanimation du malade**
- D) chirurgie en urgence
- E) **IPP en IV forte dose**

59. l'endoscopie digestive haute a été faite objectivant une perte de substance du bulbe de 1 cm avec un saignement en nappe . la classification Forrest de cet ulcère est :

- A) Ia
- B) **Ib**
- C) IIa
- D) IIb
- E) IIc

60. le traitement de première intention de cet ulcère est :

- A) hémostase endoscopique seul
- B) **hémostase endoscopique associée à un traitement à base d'IPP en IV**
- C) chirurgie
- D) IPP en IV forte dose seulement
- E) Embolisation radiologique